압타바이오

NR

293780 기업분석 |

목표주가	–	현재주가(10/26)	5,790원	Up/Downside	–

2026. 10. 27

KDIGO 개정안까지 충족한 APX115 임상 2상 결과 발표

Comments

아이수지낙시브, CI-AKI(조영제 유발 급성신손상) 임상 2상에서 안전성 및 유효성 입증: 경구용 pan-NOX 저해제인 APX115(아이수지낙시브)는 지난 ASN(미국신장학회)2026에서 유효성 평가지표인 12주 eGFR, 혈청 크레아티닌이 위약대비 통계적 유효성을 입증하였음을 발표함. 또한 AKD 발생률은 위약대비 절반 수준으로 감소하였음. 신장질환 국제 치료 가이드라인인 KDIGO2026 개정안에 따르면, 최근 급성 신손상 이후 90일까지의 신기능 회복을 중요하게 강조하고 있어 12주(약 84일) 시점의 장기 신기능 개선은 중요함. CI-CKI에 대한 치료제가 부재한 가운데 CKD로 진행 가능성을 예방하기 위한 치료제로 가능성을 제시하였다는 점에서 2상 결과는 임상적 가치가 크게 높아졌다고 판단됨. 이에 학회에서 주목받고 포스터에서 Late breaking 구두발표까지 이어졌음

급성에 이어 만성 당뇨병성 신증(DKD)까지 유효한 결과가 나온다면 의미있는 기술계약도 기대 가능: CI-AKI 연구는 내년 상반기 CSR 수령 및 FDA에 Fast Track 신청예정임. DKD 연구는 유럽 임상 2a상에서 중증 환자 대상 신기능 개선 결과를 기반으로 중등/중증 환자 대상으로 진행중. 내년 임상 2상 탑라인 결과까지 확보 목표임. 급성 및 만성 신손상에 대해 예방부터 치료까지 가능하다는 점에서 글로벌 제약사의 관심이 높을 것이라 전망함.

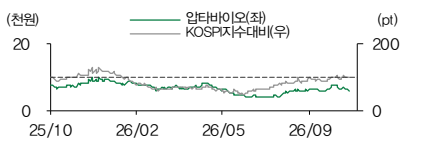
CAF 표적 면역항암제 APX343A, 키트루다 병용 임상 순항 중: 2024년 MSD와의 공급계약을 통해 진행성 고형암 대상 키트루다 병용 임상에서 APX343A는 저용량 코호트에서 안정병변(SD)이 관찰되는 등 초기 항암 활성 신호가 확인됨. 연내 환자등록 완료 후 용량증가에 따른 면역관문억제제 개발 기업과의 공동연구 등의 파트너십이 기대됨

Investment Fundamentals (IFRS연결) (단위: 십억원, 원, 배, %)

FYE Dec	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	NA	0	0	3	4
(증가율)	NA	NA	NA	NA	33.3
영업이익	NA	-10	-16	-19	-16
(증가율)	NA	NA	적지	적지	적지
순이익	NA	-11	-12	-29	-16
EPS	NA	-474	-541	-1,247	-607
PER (H/L)	NA / NA	NA / NA	NA / NA	NA / NA	NA / NA
PBR (H/L)	NA / NA	16.1/4.5	5.2/2.8	7.7/2.4	7.1/3.6
EV/EBITDA (H/L)	NA / NA	NA/NA	NA/NA	NA/NA	NA/NA
영업이익률	NA	-19,661.2	-5,055.6	-561.0	-428.4
ROE	NA	-20.2	-21.2	-50.8	-32.2

Stock Data

52주 최저/최고	4,000/10,420원
KOSDAQ /KOSPI	727/5,469pt
시가총액	1,627억원
60日-평균거래량	62,850
외국인지분율	1.3%
60日-외국인지분율변동추이	-0.2%p
주요주주	이수진 외 3 인 27.2%



주가상승률	1M	3M	12M
절대기준	-10.4	23.1	-18.3
상대기준	4.1	26.6	-0.8

Analyst 이명선 02 369 3425 mslee@dbsec.co.kr

아이수지낙시브, 만성부터 급성 신손상 환자까지 신기능 개선 효과 입증

KDIGO2026 개정안에 충족하는 임상 2상 결과

아이수지낙시브(APX-115)는 ASN2026(10/21~25, 미국신장학회)에서 조영제 유발 급성 신손상(CI-AKI) 환자 대상 임상 2상에서 안전성에 이어 성공적인 유효성 탑라인 데이터를 구두 발표하였다. 최종 임상시험 결과보고서(CSR)는 2027년 상반기 확보할 예정이다. 아이수지낙시브는 2022년 당뇨병성 신증으로 유럽 2a상을 완료한 이후 현재 중등도/중증 당뇨병성 신증 환자를 대상으로 국내 2b상 진행 중으로 내년 하반기 탑라인 도출을 목표로 하고 있다.

조영제 관련 급성신손상(CI-AKI)은 관상동맥중재술(PCI) 등 조영제를 사용하는 시술 이후 발생할 수 있는 신장 손상으로 이후 만성 신장질환 진행 및 심혈관계 합병증 위험과도 연관된다. 이에 생리식염수 기반 수액 공급, 조영제 사용량 최소화, 신독성 약물 관리 및 환자별 위험인자 조절함으로써 신손상에 대한 예방 조치를 하고 있다. 다만 N-acetylcysteine(NAC), 중탄산나트륨, 항산화제 등 다양한 약물 전략이 연구됐으나 임상적으로 의미 있는 신장 보호 효과는 일관되게 입증되지 않았다. 대표적으로 4,993명을 분석한 PRESERVE 임상에서는 중탄산나트륨이 생리식염수 대비, NAC가 위약 대비 사망 · 투석 · 지속적 신기능 저하를 포함한 주요 결과를 개선하지 못했다. 이는 CI-AKI 영역에서 새로운 기전의 약물 개발의 필요성을 강조하는 것이고, 특히 단기간의 크레아티닌 변화만으로는 임상적 유효성을 확증하기 어렵다는 점을 보여준다.

아이수지낙시브는 활성산소 생성에 관여하는 NADPH oxidase(NOX) 효소군을 억제하는 경구용 pan-NOX 저해제다. 즉, 산화 스트레스와 염증 반응을 조절해 신장 손상을 예방하고 개선시키는 치료제로 개발 중이다. 2022년 발표한 당뇨병성 신증 임상 2a상에서 중증 이상의 환자에서 UACR이 위약 대비 47% 개선 효과를 확인하였고, 이를 기반으로 CI-AKI 환자 대상으로 미국/한국 임상 2상을 진행하였다. 이미 ASN2025에서 발표한 초기 30명 센티널 코호트의 블라인드 통합분석에서 48시간 시점의 크레아티닌 상승과 12주 eGFR 감소를 유의하게 예측하였다(P=0.025). 이는 급성기 신기능 변화가 장기적인 신기능 저하와 연관될 수 있지만 치료 효과를 입증하기에는 추가적인 결과(위약 대비 eGFR 저하 억제, CI-AKI 및 급성신질환(AKD) 발생률 감소, 효과 지속성 등)가 필요하였다.

CI-AKI 임상 2상은 한국 · 미국 14개 병원에서 PCI 예정 환자 212명을 대상으로 진행하였고, 1차 평가지표 안전성 결과는 투여군과 위약군 모두 임상적으로 유의한 결과를 확인하였다. 또한 기저 eGFR 45mL/min/1.73㎡ 이하의 신기능 저하 고위험군에서도 특별한 안전성 우려가 보고되지 않았다.

유효성 평가는 시술 2일 전부터 복용해 시술 시점에 약물 농도를 안정적으로 유지하고, 기존 AKI 가이드라인에 맞추어(48-72시간 구간까지 투약 설계) 조영제 손상이 진행되는 시술(PCI) 후 48~72시간 구간까지 총 5일 투약하도록 설계하였다. 그리고 급성 신질환(AKD)에서 CKD로 전환되는 시점의 신기능을 12주 eGFR, 혈청 크레아티닌으로 확인하였고, 모두 위약대비 통계적 유의성을 보여주였다.

12주 시점 eGFR은 아이수지낙시브군이 위약 대비 5.6%p 차이(p=0.017, -1.8% vs. -7.4%)를 보였고. 혈청 크레아티닌은 투약군에서 0.03mg/dL 증가(위약 0.10mg/dL)하면서 통계적 유의성(p=0.028)을 확보하였다. 신기능을 나타내는 두 지표는 같은 방향성을 보여주었으며, 조영술 직후 AKI 발생률은 두 군이 비슷한 수준이었으나, 이후 신기능 저하가 지속되는 급성 신질환(AKD) 발생은 아이수지낙시브군에서 위약군의 절반 수준으로 관찰되면서 신장개선 효과를 확인할 수 있었다. 이러한 임상 설계는 KDIGO가 2026년 개정안에서 급성 손상 이후 90일까지의 신기능 회복을 확인해야한다는 내용과 일치한다.

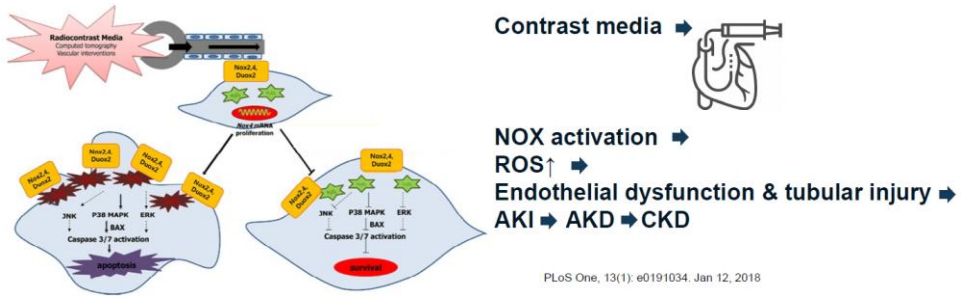
급성 신손상은 시술 직후의 손상(AKI)에서 끝나지 않고, 7~90일의 회복기(AKD)를 거쳐 회복되지 않으면 만성콩팥병(CKD)으로 이어지는 하나의 Continuum이며, KDIGO 2026 개정안 역시 이 개념을 전면에 내세우고 손상 이후 90일까지의 신기능 회복을 중요하게 강조하고 있다. 본 임상 2상 디자인은 이러한 처방 가이드라인의 취지와 변화를 사전에 반영하여 AKI 치료제 중 최초로 성공적인 결과를 도출하였다는 점에서 의미가 크다. 조영술 직후 AKI 발생률은 두 군이 비슷했지만, 신기능 저하가 이어지는 AKD 발생은 위약군의 절반 수준으로 관찰되었고, AKD 구간에 해당하는 12주(약 84일) 시점 eGFR 감소폭이 위약군과 뚜렷한 차이를 보였다. 이는 투약이 끝난 뒤에도 두 군의 eGFR 격차가 4주보다 12주에 더 벌어지면서 AKI가 CKD로 진행되는 AKD 진행을 차단하고 있다고 해석된다. 특히, 만성화 위험이 가장 큰 eGFR 60 미만 고위험군에서 위약군이 12주 만에 9.7% 감소하는 반면 약물군은 0.9% 감소에 그쳐 차이가 8.9%p(p=0.012)까지 확대되었다. 이는 당뇨병성 신증 임상 2a상에서 신기능이 낮은 환자일수록 알부민뇨(UACR) 개선 폭이 컸던 결과와 같은 양상이다. 급성 신손상의 회복과 만성 신질환의 지연을 하나의 약물로 가능하다는 점에서 아이수지낙시브는 AKI-AKD-CKD Continuum 전체를 아우르는 최초의 신약으로 거듭날 수 있는 가능성이 있다고 전망된다. 또한 진행 중인 당뇨병성 신증 임상 2b상의 성공 가능성과 패키지 기술이전의 가치 모두 한층 높아졌다고 판단할 수 있는 근거가 마련되었다.

도표 1. 아이수자낙시브, 당뇨병성 신증 및 조영제 유발 급성 신손상 임상 2상 개발

플랫폼		적응증	프로그램	개발 단계				
				Discovery	IND-Enabling	임상 1상	임상 2상	임상 3상
NOX 저해제 플랫폼	Oxidative stress Modulation	Diabetic Nephropathy	APX-115 (Isuzinaxib)	임상 2b상 진행 중(MFDS)				
		Acute Kidney Injury	APX-115 (Isuzinaxib)	2026 임상 2상 종료(FDA, MFDS)				

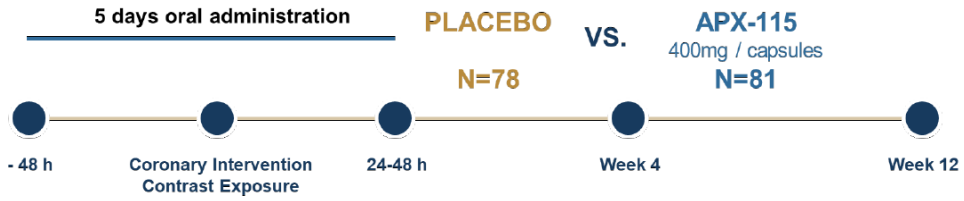
자료: 압타바이오, DB 증권

도표 2. 아이수자낙시브 작용기전



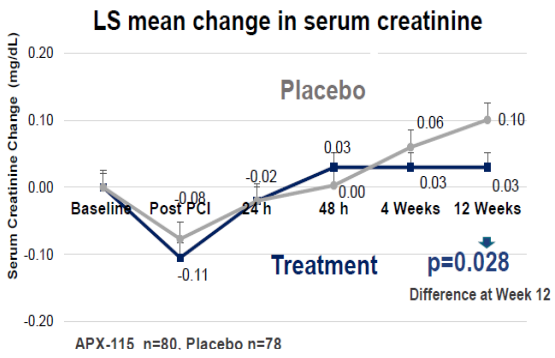
자료: ASN2026, 압타바이오, DB증권

도표 3. 아이수자낙시브 CI-AKI 임상 2상 디자인



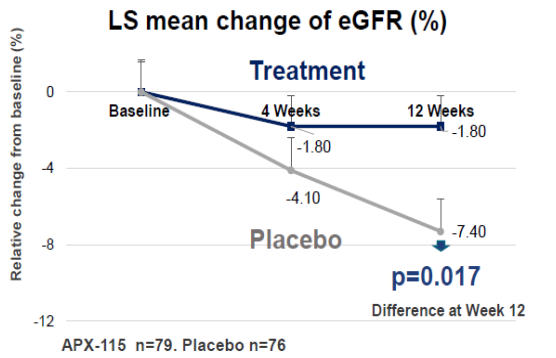
자료: ASN2026, 압타바이오 DB증권

도표 4.아이수지낙시브 혈중 크레아티닌 변화



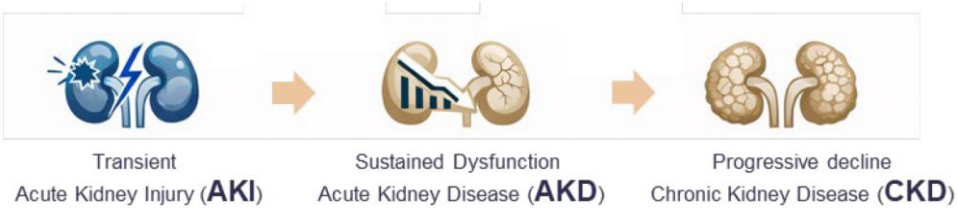
자료:ASN2026, 압타바이오, DB증권

도표 5. 아이수지낙시브, eGFR 변화



자료: ASN2026,압타바이오, DB증권

도표 6. AKI–AKD–CKD Continuum



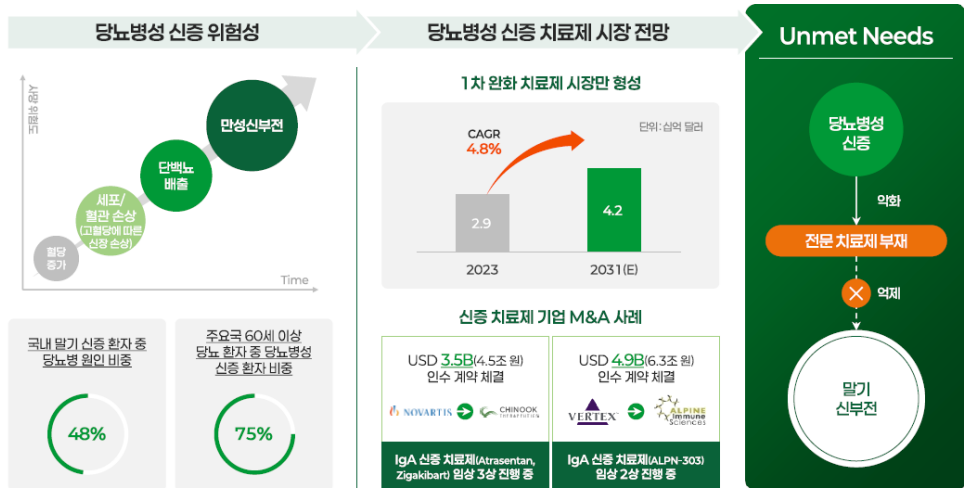
발생 ~ 7일	발생 7 ~ 90일	발생 90일 이상
serum creatinine	persistent eGFR decline Kidney damage markers	eGFR decline albuminuria (UACR)

자료: ASN2026, 압타바이오, DB증권

당뇨병성 신증, 중등도 이상 환자에서 유효성 결과 기대

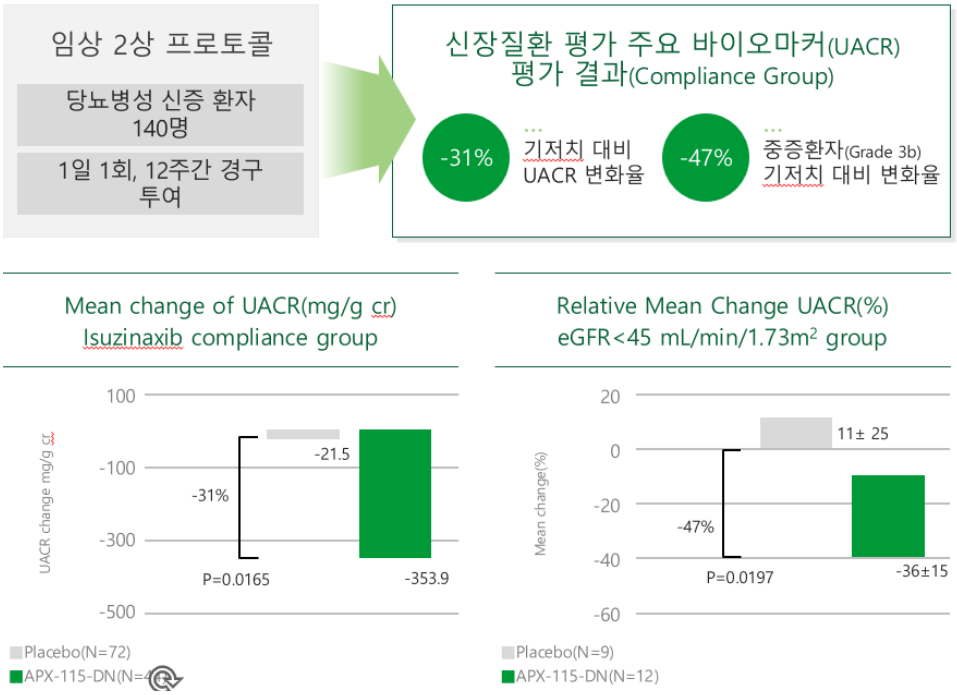
아이수지낙시브는 과거 유럽 당뇨병성 신증 임상 2상에서 140명 환자군에서 12주 후 UACR이 APX-115군 20.6%, 위약군 2.5% 감소했으나 군간 차이는 통계적으로 유의하지 않았다(P=0.088). 다만 eGFR 45mL/min/1.73㎡ 미만의 중증 환자 대상의 소규모 하위군에서는 47% UACR 감소로 긍정적인 신호가 관찰되었다. 이에 중등도/중증 당뇨병성 신증 환자 대상 국내 임상 2상을 2024년 12월에 IND 승인받았고, 147명 대상으로 진행 중이다. 이미 임상 2a에서 12주 UACR로 신장기능 개선 효과를 간접적으로 확인하였고, CI-AKI로 12주 eGFR 개선 효과를 확인하였다. 특히 2a와 유사한 40% 중반대의 UACR 개선효과가 확인된다면, 기존 카렌디아, SGLT2 저해제 등의 30% 중반보다 우수한 신기능 개선 효과를 입증하게 되는 것이다. 특히 카렌디아의 경우 고칼륨혈증 등 부작용으로 치료 어려움이 있다는 점에서 아이수지낙시브는 충분한 대안이 될 수 있을 것이라 생각된다.

도표 7. 아이수자낙시브, 당뇨병성 신증 시장



자료: 압타바이오, DB 증권

도표 8. 아이수자낙시브 당뇨병성 신증에 대한 유럽 임상 2a 결과: 중증환자에서 UACR 개선도 높음



자료: 압타바이오, DB증권

도표 9. 만성 신장질환에 대한 기술계약 사례

(단위: 억 달러)

인수 기업	일자	피인수기업	파이프라인	작용 기전	계약 규모
Akebia	2021	Cyclerion	Praliciguat	경구 sGC 자극제	L/O, 5.85
AstraZeneca	2023.01	CinCor	Baxdrostat	SGLT2 억제제 병용	M&A, 18
Novartis	2023.06	Chinook Therapeutics	Astrasentan, Zigakibart	최초의 선택적 ETAR 길항제, 항-APRIL 단일클론항체	M&A, 35
Novartis	2025.05	Regulus Therapeutics	Farabursen	miR-17 타깃, 올리고뉴클레오타이드 기반 약물	M&A 계약금 8, CVR 9
Novartis	2025.10	Avidity Biosciences	신경근육질환	RNA 타깃 전달 플랫폼 AOC 기술	M&A, 120
Vertex	2024.04	Alpine Immune Sciences	Povetacicept	BAFF와 APRIL 사이토카인 2중, IgA 신증 2상에서 최고 수준의 효능 가능성	M&A, 49
Asahi Kasei	2024.05	Calliditas Therapeutics	Tarpeyo, Setanaxib	IgA 신증 치료제, NOX1/4 저해제	M&A, 11
Asahi Kasei	2019.11	Veloxis Pharmaceuticals	Envarsus XR	신장이식 환자 면역반응 억제제	M&A, 13
Biogen	2026.03	Apellis	APL-3007	siRNA 치료제, 지리위축 환자 Syfovre 병용 투여	M&A, 56

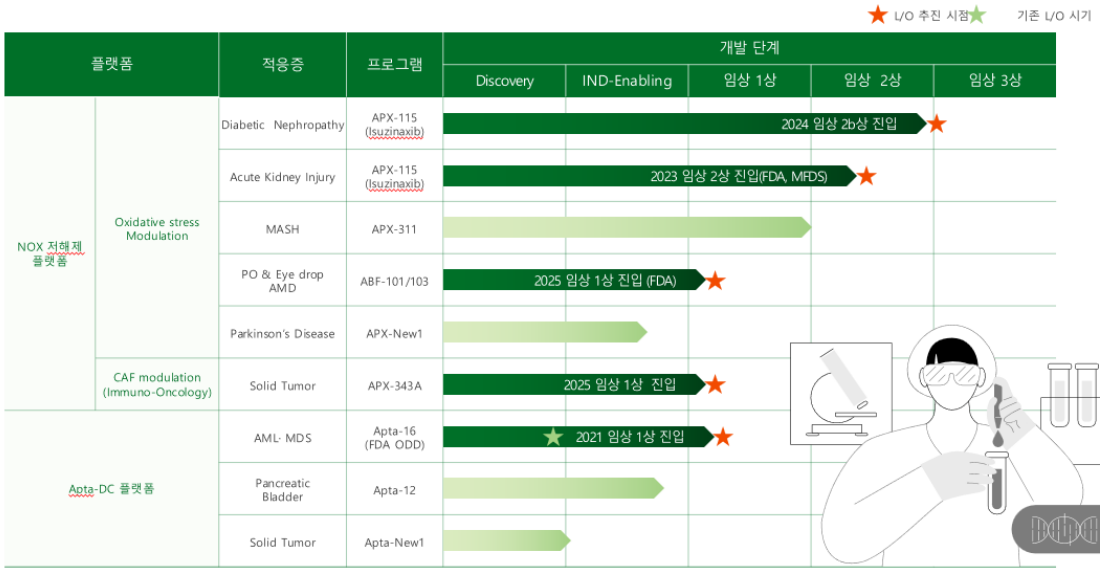
자료: 각 사, DB 증권

치료제가 부재한 급성 신손상 관련 적응증 확대 기대도 가능

아이수지낙시브는 급성 신손상은 원인과 관계없이 손상 초기에 NOX가 활성화되고 산화스트레스가 손상을 키운다는 공통 기전으로 개발된 약물이다. 조영제를 사용한 영상검사(CT 등)에 대한 급성 신손상뿐 아니라 심장수술 관련 급성 신손상(CSA-AKI), 항암제(시스플라틴 등) 유발 신독성, 신장이식 후 이식신 기능 지연(DGF), 패혈증 관련 급성 신손상 등으로 개발 확장할 수 있다.

급성 신손상 시장규모는 승인된 약물 없이도 관련된 투석, 수액/지지요법, 입원 등을 고려할 때 2031년 약 93억 달러로 연평균 4.1% 성장할 것으로 전망하고 있다. 2020년 Vifor Pharma는 Angion Biomedica으로 부터 심장수술 관련 급성신손상(CSA-AKI)과 이식신 기능 지연 치료제 ANG-3777를 약 3.4억 달러 규모(중국 제외 글로벌 권한, 선급금 0.3억 달러, 지분투자 0.3억 달러, 마일스톤 최대 2.6억 달러, 로열티 별도로 최대 40%)에 기술도입 계약이 체결되었다. 또한 2026년 7월 Mission Therapeutics는 임상 1상의 급성 신손상 치료 후보물질인 MTX652를 Dimerix에 최대 2.92억 달러에 기술이전한 사례가 있다.

도표 10. 압타바이오 신약 파이프라인 개발 현황



자료: 압타바이오, DB 증권

Appendix: 용어 설명

eGFR(추정 사구체여과율): 신장의 사구체가 1분 동안 걸러내는 혈액의 양을 혈중 크레아티닌, 나이, 성별로 추정한 값임(단위: mL/min/1.73m²). 신장 기능을 가장 직접적으로 보여주는 대표 지표로, 수치에 따라 만성콩팥병을 1기(90 이상)부터 5기(15 미만)까지 5단계로 구분함. 병기가 높아질수록 노폐물이 혈액에 쌓이고, 5기에 이르면 투석이나 신장이식이 필요한 말기신부전이 됨. 만성 신장질환에서는 eGFR이 천천히 변해 12주나 24주 같은 짧은 기간에는 차이를 확인하기 어려워, 신약 임상에서는 대개 1년 이상 장기간에 걸친 변화율을 주요 평가지표로 봄

혈중 크레아티닌: 근육에서 만들어져 신장을 통해 배설되는 노폐물임. 신장 기능이 떨어지면 몸 밖으로 빠져나가지 못해 혈중 농도가 올라감. 정상 범위가 1mg/dL 안팎으로 작아 작은 변화도 신기능 변화를 반영하며, eGFR 계산과 급성 신손상 진단의 기준이 됨

UACR(소변 알부민–크레아티닌 비율): 소변 속 알부민과 크레아티닌의 비율임(단위: mg/g). 사구체가 손상되면 걸러져야 할 알부민이 소변으로 새어 나오는데, 그 정도를 보여줌. 30 미만은 정상, 30~300은 중등도, 300 초과는 고도 증가로 분류함. 알부민뇨가 줄어들면 신기능 악화 속도도 늦어지는 것으로 알려져 있어, 당뇨병성 신증 신약의 임상 2상에서 약효를 확인하는 주요 평가지표로 쓰이며, 이후 3상에서는 eGFR 등 장기 신기능 지표로 최종 효과를 확인함

KIM–1(신장 손상 분자–1): 신장 세뇨관이 손상되면 세포 표면에 나타나 소변으로 배출되는 단백질임. 혈중 크레아티닌보다 먼저 변화해 세뇨관 손상을 이른 시점에 확인할 수 있는 바이오마커로, 미국 FDA가 약물에 의한 신장 손상을 평가하는 지표로 인정한 바 있음

AKI(급성 신손상): 신장 기능이 갑자기 떨어지는 상태. 국제 진료지침(KDIGO) 기준으로는 48시간 안에 혈중 크레아티닌이 0.3mg/dL 이상 오르거나, 7일 안에 기저치의 1.5배 이상 증가하는 경우 등으로 진단함

CI–AKI(조영제 유발 급성 신손상): 관상동맥 중재술(PCI)이나 CT 촬영처럼 혈관에 조영제를 넣는 시술 · 검사 뒤에 생기는 급성 신손상임. 신기능이 떨어진 환자, 당뇨병 환자, 고령 환자에게서 위험이 높음. 현재 예방 약물로 승인된 치료제가 없어, 시술 전후 수액을 공급하는 것이 사실상 유일한 대응법임

AKD(급성 신질환): 급성 신손상 이후 7일에서 90일까지 신기능이 회복되지 않고 저하된 상태가 이어지는 것을 말함. AKI와 만성콩팥병 사이의 중간 단계로, 90일을 넘기면 정의상 만성콩팥병으로 분류됨. 초기 검사에서 AKI 기준에 해당하지 않았던 환자도 이후 신기능이 계속 떨어져 AKD로 진행할 수 있어, AKI 발생 여부만으로는 신장 손상을 충분히 평가하기 어려움. 이 때문에 초기에 AKI가 생겼는지보다 이후 AKD로 이어지는지가 장기적인 신기능 저하, 만성콩팥병 진행, 사망 위험과 더 밀접하게 연관된 것으로 보며, 급성 신손상 이후의 회복을 평가하는 핵심 지표로 주목받고 있음. KDIGO도 2026년 급성 신손상 지침 개정안에서 AKD 단계의 관리를 중요하게 다룸

AKI–AKD–CKD 연속성(Continuum): 급성 신손상(AKI), 급성 신질환(AKD), 만성콩팥병(CKD)을 별개의 질환이 아니라 하나로 이어지는 경과로 보는 개념임. 손상 직후의 급성기(AKI)와 7~90일의 회복기(AKD)를 거쳐, 90일 이후에도 회복되지 않으면 만성콩팥병(CKD)으로 넘어감. 이 관점에서는 손상이 생겼는지보다 손상 이후 신기능이 회복되는지가 장기 예후를 좌우하므로, 회복기에 신기능 저하를 막는 것이 만성화를 막는 치료 목표가 됨. 기존 급성 신손상 예방 임상은 주로 시술 후 48~72시간 안에 AKI가 생겼는지를 평가해 왔음

CKD(만성콩팥병): 신장 손상이나 신기능 저하(eGFR 60 미만)가 3개월 이상 이어지는 상태임. 당뇨병과 고혈압이 주요 원인이며, 진행되면 말기신부전으로 이어짐. 미국에서는 만성콩팥병과 말기신부전 관련 지출이 공공의료보험(Medicare) 지출의 20% 이상을 차지할 만큼 의료비 부담이 큰 질환으로, 질환 진행을 늦춰 투석으로 넘어가는 환자를 줄이는 것이 주요 보건 과제로 꼽힘

KDIGO(Kidney Disease: Improving Global Outcomes): 신장질환 분야의 국제 진료지침을 만드는 비영리 국제기구임. 만성콩팥병과 급성 신손상의 진단 기준, 병기 분류, 치료 원칙을 제시함. 2026년 급성 신손상 지침 개정안에서는 AKI · AKD · CKD를 하나의 연속된 경과로 보고, 손상 이후 90일까지의 신기능 회복을 중요하게 강조함

PCI(관상동맥 중재술): 좁아지거나 막힌 심장 혈관에 카테터를 넣고 풍선이나 스텐트로 넓히는 시술임. 시술 과정에서 혈관을 보기 위해 요오드 조영제를 사용하는데, 조영제가 신장 세뇨관에 직접 독성을 주고 신장 혈류를 줄여 산소 부족과 산화스트레스를 일으키면서 급성 신손상이 생길 수 있음. 이 때문에 PCI는 조영제 유발 급성 신손상의 대표적인 원인이 됨

NOX(NADPH 산화효소)와 Pan-NOX 저해제: NOX는 세포에서 활성산소를 만드는 효소군으로, 질환 상태에서 과도하게 활성화되면 염증, 섬유화, 신생혈관 형성 등을 일으키는 출발점 역할을 함. 신장이 손상될 때도 NOX가 활성화돼 산화스트레스와 염증, 섬유화를 키움

대차대조표

12월 결산(십억원)	2021	2022	2023	2024	2025
유동자산	NA	20	57	35	25
현금및현금성자산	NA	2	25	26	16
매출채권및기타채권	NA	0	0	1	1
재고자산	NA	0	0	0	1
비유동자산	NA	36	35	42	35
유형자산	NA	5	5	5	6
무형자산	NA	0	0	0	1
투자자산	NA	28	26	34	26
자산총계	NA	56	93	77	60
유동부채	NA	1	1	20	10
매입채무및기타채무	NA	1	1	5	3
단기차입금및단기사채	NA	0	0	7	4
유동성장기부채	NA	0	0	0	0
비유동부채	NA	3	30	4	3
사채및장기차입금	NA	0	14	0	0
부채총계	NA	4	31	23	13
자본금	NA	11	12	13	14
자본잉여금	NA	109	130	150	158
이익잉여금	NA	-68	-81	-110	-126
비지배주주지분	NA	0	0	0	0
자본총계	NA	52	61	54	47

현금흐름표

12월 결산(십억원)	2021	2022	2023	2024	2025
영업활동현금흐름	NA	-7	-14	-12	-15
당기순이익	NA	-11	-12	-29	-16
현금유출이없는비용및수익	NA	5	8	22	21
유형및무형자산상각비	NA	0	1	1	0
영업관련자산부채변동	NA	0	-1	3	-4
매출채권및기타채권의감소	NA	0	0	-1	0
재고자산의감소	NA	0	0	0	0
매입채무및기타채무의증가	NA	0	0	3	-2
투자활동현금흐름	NA	2	-13	13	6
CAPEX	NA	1	0	0	0
투자자산의순증	NA	-28	2	-8	9
재무활동현금흐름	NA	0	50	0	-1
사채및차입금의 증가	NA	0	27	-12	-8
자본금및자본잉여금의증가	NA	120	21	22	9
배당금지급	NA	0	0	0	0
기타현금흐름	NA	0	0	0	0
현금의증가	NA	-5	23	1	-9
기초현금	NA	7	2	25	26
기말현금	NA	2	25	26	16

손익계산서

12월 결산(십억원)	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	NA	0	0	3	4
매출원가	NA	0	0	3	2
매출총이익	NA	0	0	0	1
판관비	NA	3	4	5	7
영업이익	NA	-10	-16	-19	-16
EBITDA	NA	-9	-16	-18	-15
영업외손익	-	-1	1	-9	0
금융손익	NA	-1	2	-7	3
투자손익	NA	0	0	0	1
기타영업외손익	NA	0	-1	-2	-4
세전이익	NA	-11	-15	-28	-15
중단사업이익	NA	0	0	0	0
당기순이익	NA	-11	-12	-29	-16
지배주주지분순이익	NA	-11	-12	-29	-16
비지배주주지분순이익	NA	0	0	0	0
총포괄이익	NA	-10	-12	-29	-16
증감률(%YoY)					
매출액	NA	NA	569.8	937.8	10.0
영업이익	NA	NA	적지	적지	적지
EPS	NA	NA	적지	적지	적지

주: K-IFRS 회계기준 개정으로 기존의 기타영업수익/비용 항목은 제외됨

주요 투자지표

12월 결산(원 %, 배)	2021	2022	2023	2024	2025
주당지표(원)					
EPS	NA	-474	-541	-1,247	-607
BPS	NA	2,349	2,630	2,016	1,680
DPS	NA	0	0	0	0
Multiple(배)					
P/E	NA	NA	NA	NA	NA
P/B	NA	4.5	3.4	3.2	5.6
EV/EBITDA	NA	NA	NA	NA	NA
수익성(%)					
영업이익률	NA	-19,661.2	-5,055.6	-561.0	-428.4
EBITDA마진	NA	-18,659.0	-4,889.1	-545.2	-415.4
순이익률	NA	-21,849.3	-3,724.2	-874.1	-442.0
ROE	NA	-20.2	-21.2	-50.8	-32.2
ROA	NA	-18.8	-16.2	-34.6	-23.8
ROIC	NA	-147.0	-125.6	-148.7	-159.0
안정성및기타					
부채비율(%)	NA	7.1	50.8	42.9	27.2
이자보상배율(배)	NA	-2,116.4	-13.8	-5.5	-7.5
배당성향(%)	NA	0.0	0.0	0.0	0.0

자료: 압타바이오, DB 증권 주: IFRS 연결기준

Compliance Notice

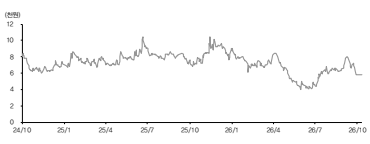
- 자료 발간일 현재 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 본 자료를 작성한 조사분석담당자는 2026년 10월 21일~10월 25일 ASN 2026에 참석하여 압타바이오로브터 비용을 제공받은 사실이 있습니다.
- 당사는 자료 발간일 현재 자난 1년간 위 조사분석자료에 언급한 종목들의 IPO 대표주관업무를 수행한 사실이 없습니다.
- 당사는 자료 발간일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 자료 발간일 현재 조사분석자료에 언급된 법인과 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 제2조 제3호에 따른 계열회사의 관계에 있지 않습니다.
- 동 자료내용은 기관투자가 등 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.
- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.
- 본 조사자료는 고객의 투자참고용으로 작성된 것이며, 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 어떠한 경우에도 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사자료는 당사의 허락없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.
- 발행주식수 변동 시 목표주가와 괴리율은 수정주가를 기준으로 산출하였습니다.

1년간 투자의견 비율 (2026-10-01 기준) - **매수**(95.3%) **중립**(4.7%) **매도**(0.0%)

기업 투자의견은 향후 12개월간 당사 KOSPI 목표 대비 초과 상승률 기준임
- **Buy**: 초과 상승률 10%p 이상
- **Hold**: 초과 상승률 -10~10%p
- **Underperform**: 초과 상승률 -10%p 미만

업종 투자의견은 향후 12개월간 당사 KOSPI 목표 대비 초과 상승률 기준임
- **Overweight**: 초과 상승률 10%p 이상
- **Neutral**: 초과 상승률 -10~10%p
- **Underweight**: 초과 상승률 -10%p 미만

압타바이오 현주가 및 목표주가 차트



최근 2년간 투자의견 및 목표주가 변경

일자	투자의견	목표주가	괴리율(%) 평균	괴리율(%) 최고/최저	일자	투자의견	목표주가	괴리율(%) 평균	괴리율(%) 최고/최저

주: *표는 담당자 변경